



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



Achar o gatilho · DICE · segurança

Saúde do Idoso

BPSD: sintomas neuropsiquiátricos nas demências

Comportamento é comunicação — antes do remédio, ache o gatilho

TEMA	Sintomas psicológicos e comportamentais da demência (SPCD/BPSD): manejo
AUTOR	Prof. Dr. Igor Moraes — CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254; Clínica Médica; Cardiologia)
DISCIPLINA	Saúde do Idoso — 9º período
INSTITUIÇÃO	FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CARGA HORÁRIA	35 minutos (panorâmica)
DATA / VERSÃO	2026 · v1.0

Idosa com demência fica agitada e agressiva ao entardecer — “é da doença, doutor?”



Foto ilustrativa • CC0

Sra. R., 80 anos • Alzheimer moderado

Toda tarde grita, quer “ir embora”, empurra a filha.

Filha exausta pede “um calmante”.

Antes de prescrever, pergunte:



O que exatamente acontece? (descrever)



Tem dor, fome, bexiga cheia, infecção?



Que horas / o que dispara? (entardecer)



Há risco para ela ou para a filha?

“Calmante” não é a 1ª resposta — o gatilho é. A Sra. R. nos acompanha a aula.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final, você maneja BPSD com método e segurança



Reconhecer

1

a fenomenologia dos BPSD e seu impacto.



Avaliar + achar a causa

2

NPI; sempre buscar gatilho (dor, delirium, fármaco, ambiente).



Aplicar

3

manejo não-farmacológico de 1ª linha (método DICE).



Usar com segurança

4

fármaco: indicação, dose, riscos (black box); cautela no DCL.



Construir

5

o plano com o cuidador e prevenir crises.

Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz.

MAPA DA AULA

O que são → achar a causa → DICE → fármaco seguro → cuidador



Fármaco é o último passo — e nunca a única medida.

BPSD: quase universais — e o maior motor de sofrimento e institucionalização

~90%

dos pacientes têm BPSD ao longo da doença

↑ sobrecarga

do cuidador e burnout



institucionalização
e custos de cuidado



Foto ilustrativa · CC BY-SA



Por que tratar bem muda o curso

Os BPSD pioram cognição e funcionalidade, precipitam quedas, hospitalização e contenção, e adoecem o cuidador. Manejá-los é cuidar do paciente E de quem cuida.

BPSD = Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (SPCD em português).

Os BPSD são muitos — agrupe para reconhecer e medir



Agitação/agressão

inquietação, gritos, resistência, hetero/auto



Psicose

delírios (roubo, infidelidade), alucinações



Depressão/ansiedade

tristeza, choro, medo, “grudado”



Apatia

perda de iniciativa e interesse (a + comum)



Sono / sundowning

inversão dia-noite, piora ao entardecer



Perambulação/desinibição

vagar, sair, condutas sociais/sexuais

Instrumento de escolha: NPI (Inventário Neuropsiquiátrico) — também mede o impacto no cuidador.

Caracterize o sintoma antes de agir — 4 perguntas



O QUÊ / quanto

sintoma exato, frequência e gravidade (NPI)



QUANDO / ONDE

horário, local, quem está presente (padrão)



GATILHO

o que precede? (dor, demanda, ruído, troca)



RISCO

perigo para o paciente/cuidador → prioridade

Use o cuidador como “sensor”: um diário de comportamento (hora, gatilho, o que ajudou) vale ouro.

2 · ACHAR A CAUSA

“Comportamento é comunicação”: procure a causa antes do rótulo



Dor

a causa nº 1 esquecida — trate empiricamente se suspeita



Delirium / doença

infecção (ITU, pneumonia), metabólico — exclua!



Fármacos

anticolinérgicos, recém-introduzidos, abstinência



Desconforto

fome, sede, constipação, bexiga cheia, frio/calor



Ambiente

ruído, excesso/falta de estímulo, mudanças, escuro



Comunicação/demanda

tarefa difícil, abordagem apressada, não entender

Boa parte dos BPSD “some” quando a dor, a infecção, a constipação ou o fármaco-gatilho são tratados.

3 · MÉTODO DICE (NÃO-FARMACOLÓGICO 1ª LINHA)

DICE: um ciclo para manejar BPSD com o cuidador



É um CICLO: se não melhora, volte a Describe/Investigate — não pule direto para o fármaco.

3 · NÃO-FARMACOLÓGICO (1ª LINHA)

O que realmente funciona — e custa pouco



Ambiente & rotina

- Rotina previsível; ambiente calmo e iluminado
- Reduzir ruído/superestimulação; sinalização
- Segurança: travas, retirar riscos (perambulação)



Atividade & abordagem

- Atividade significativa, música, reminiscência
- Exercício/luz natural; higiene do sono
- Comunicação simples, validar, não confrontar



Cuidador

- Psicoeducação: o sintoma é da doença
- Técnicas de manejo e de desescalada
- Apoio, pausa (respiro), tratar a sobrecarga

Evidência: medidas não-farmacológicas e centradas na pessoa têm o melhor risco-benefício na maioria dos BPSD.

Agitação/agressão: desescalar, proteger, achar o gatilho



Não-farmacológico primeiro

- Postura calma; um interlocutor; tom baixo
- Distrair/redirecionar; remover o gatilho
- Tratar dor empiricamente se suspeita
- Garantir segurança (espaço, retirar objetos)



Quando considerar fármaco

- Sofrimento intenso OU risco à segurança
- Falha das medidas não-farmacológicas
- Alvo claro, dose baixa, prazo definido
- Reavaliar e desprescrever (ver slides de fármaco)

Psicose (delírios/alucinações): tratar só quando incomoda ou é perigosa



Como conduzir

- Nem todo delírio/alucinação precisa de fármaco
- Não confronte; valide o sentimento, reoriente suave
- Cheque visão/audição e delirium (alucinação nova)
- Trate se há sofrimento, agressão ou risco



Alerta: corpos de Lewy

- Alucinação visual precoce sugere DCL
- HIPERSENSIBILIDADE a antipsicóticos — reação grave
- Evitar típicos; se necessário, atípico em dose mínima
- Considerar inibidor de colinesterase (pode ajudar)

Depressão, apatia e ansiedade: diferencie — o manejo é diferente



Depressão

- Tristeza, choro, anedonia, culpa
- Rastrear (Cornell na demência)
- ISRS se moderada-grave; psicossocial



Apatia

- Perda de iniciativa SEM tristeza (≠ depressão)
- A mais comum; muito subdiagnosticada
- Estímulo/atividade estruturada; evitar “forçar”



Ansiedade

- Inquietude, “grudado”, perguntas repetidas
- Buscar gatilho/insegurança; rotina
- Evitar benzodiazepínico de rotina

Apatia ≠ depressão: forçar atividade na apatia frustra; tratar como depressão (ISRS) costuma não ajudar.

Sono, sundowning e perambulação: luz, rotina e segurança



Higiene do sono

luz natural de dia, atividade; quarto escuro/silencioso à noite



Sundowning

iluminar o fim de tarde; reduzir ruído/estímulo; atividade calmante; evitar cochilos longos



Perambulação

ambiente seguro (travas, alarmes, ID); permitir caminhar com supervisão



Evitar

hipnótico/benzo de rotina, cafeína à tarde, contenção física

Sundowning da Sra. R. — qual o primeiro passo?

Pistas

- Agitação só ao entardecer
- Casa escura e barulhenta nesse horário
- Constipada há 4 dias; sem febre
- Sem risco imediato de agressão grave

Conduta inicial

A

Iniciar risperidona ao entardecer

B

DICE: tratar constipação + iluminar/reduzir ruído à tarde + rotina/atividade calmante; reavaliar

C

Benzodiazepínico “de horário”

Resposta: B — causas (constipação/ambiente) + não-farmacológico antes do fármaco.

Se for usar fármaco: princípios inegociáveis



Alvo claro

sintoma definido (ex.: agressão), não “sedar”



Start low, go slow

menor dose; titular devagar; um de cada vez



Prazo definido

reavaliar em dias-semanas; tentativa de retirada



Consentimento

risco×benefício com família; documentar



Reavaliar/desprescrever

BPSD flutuam e remitem; não perpetue

Fármaco é adjuvante do não-farmacológico — nunca substitui achar a causa.

Antipsicóticos: eficácia modesta e risco real (black box)



Foto ilustrativa · CC BY-SA



Black box (FDA)

↑ mortalidade e AVC em idosos com demência — vale p/ típicos e atípicos



CATIE-AD

benefício modesto; efeitos adversos frequentemente anulam o ganho



Indicação restrita

agressão/psicose com sofrimento ou risco, após falha não-farmacológica



Monitorar

sedação, quedas, extrapiramidal, metabólico, QT; reavaliar sempre

Fonte: FDA boxed warning (2005/2008); CATIE-AD (Schneider et al., NEJM 2006).

4 · OPÇÕES FARMACOLÓGICAS

O que usar, com parcimônia — e o que evitar



Brexpiprazol

1º aprovado pela FDA (2023) p/ agitação na DA; mantém black box



Risperidona

atípico mais estudado p/ agressão; curto prazo, dose baixa



Citalopram (ISRS)

agitação (estudo CitAD); cuidado com QT (≤ 20 mg no idoso)



Inibidor de colinesterase/memantina

modesto; pode ajudar (esp. no DCL)



EVITAR

antipsicótico no DCL (típicos), benzo de rotina, anticolinérgico

Doses e escolhas dependem de função renal/hepática, interações, QT e protocolo local — individualize.

Erros comuns que pioram o paciente



Antipsicótico de 1ª linha

sem investigar causa nem tentar não-farmacológico



Benzodiazepínico de rotina

↑ confusão, quedas, dependência, desinibição paradoxal



Anticolinérgicos

pioram cognição e podem causar delirium



Contenção física

↑ agitação, lesão, imobilidade — último recurso pontual



Polifarmácia/“empilhar”

somar psicotrópicos sem reavaliar



Perpetuar o fármaco

manter sem tentativa de retirada

Agressão física que põe a cuidadora em risco — e agora?

Passo a passo

- 1. Segurança imediata (espaço, ajuda, retirar risco)
- 2. Excluir causa aguda: dor, ITU, retenção, delirium
- 3. Desescalar (1 interlocutor, calma, redirecionar)
- 4. Se persiste risco/sofrimento: fármaco-alvo, dose baixa, prazo

Pontos-chave

- Segurança e causa vêm ANTES do antipsicótico
- Se for medicar: risperidona dose baixa, curto prazo, consentido
- Se há sinais de DCL: NÃO usar típico; cautela máxima
- Documentar alvo, risco×benefício e data de reavaliação
- Contenção física: só último recurso, pontual e monitorada

Tratar o BPSD é também cuidar de quem cuida



Enfermeira e idoso · domínio público (DOCUMERICA)



Psicoeducação

entender que o sintoma é da doença reduz culpa e conflito



Treino de manejo

comunicação, rotina, desescalada, segurança em casa



Apoio & respiro

rede, grupos, pausa; rastrear e tratar a SOBRECARGA (Zarit)



Prevenir crise

plano escrito: o que fazer, quem chamar, sinais de alarme

O erro nº 1: sedar o comportamento sem escutar a causa



A armadilha

“Calmante” para a agitação

→ mascara a dor/ITU/constipação, seda, derruba, e a black box cobra o preço.



Como evitar

- Comportamento é comunicação: descreva e investigue
- Não-farmacológico 1º; fármaco com alvo/dose/prazo
- Trate dor; cheque DCL antes de antipsicótico



Curiosidade: o método DICE virou referência mundial por uma razão simples — transforma “o que dar?” em “por que ele faz isso?”. A pergunta certa muda o tratamento.

Como manejar BPSD em uma frase

Comportamento é **COMUNICAÇÃO** — antes do remédio, ache o **GATILHO**. Use o ciclo DICE.



Achar a causa

dor, delirium/infecção, fármacos, desconforto, ambiente. Trate-os primeiro.



Não-farmacológico 1º

DICE; ambiente/rotina/atividade; cuidador como coterapeuta.



Fármaco com segurança

alvo/dose baixa/prazo; black box; brexpiprazol/citalopram; EVITAR no DCL.

Teste rápido: Q1 a Q3

Q1

Idoso com demência subitamente agitado, sem outra causa óbvia. 1º passo?

A) Antipsicótico B) Procurar causa (dor/ITU/constipação/fármaco) C) Benzo D) Contenção

Q2

Demência com alucinações visuais precoces e parkinsonismo, agitado. Evitar?

A) ISRS B) Antipsicótico típico (risco no DCL) C) Medidas ambientais D) Inibidor de colinesterase

Q3

Qual a 1ª linha para a maioria dos BPSD?

A) Antipsicótico B) Benzodiazepínico C) Não-farmacológico (DICE) D) Contenção

Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.

Mais três e os comentários

Q4. Perda de iniciativa SEM tristeza. Sintoma?

Q5. 1º fármaco aprovado pela FDA p/ agitação na DA?

Q6. Antipsicóticos na demência: principal risco?

Gabarito comentado

Q1 → B — Comportamento é comunicação: ache a causa antes do fármaco.

Q2 → B — DCL: hipersensibilidade a antipsicótico típico (reação grave).

Q3 → C — Não-farmacológico (DICE) é 1ª linha na maioria dos BPSD.

Q4 → Apatia — Sem tristeza; não responde a antidepressivo como a depressão.

Q5 → Brexpiprazol — FDA 2023 p/ agitação na DA; mantém black box.

Q6 → Black box — ↑ mortalidade/AVC; eficácia modesta (CATIE-AD).

Recapitule agora — e revise nos próximos dias

Em 30 segundos, recupere de memória:

- A frase-âncora e o ciclo DICE
- 5 causas a procurar antes do fármaco
- Riscos dos antipsicóticos (black box)
- O que EVITAR no DCL



3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Quais causas reversíveis procurar na agitação?
2. O que é o DICE e como aplicá-lo?
3. Quando (e como) usar antipsicótico com segurança?

REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

Referências

1. Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. Assessment and management of behavioral and psychological symptoms of dementia. BMJ. 2015;350:h369.
2. Kales HC, et al. Management of BPSD: DICE approach (panel de especialistas). J Am Geriatr Soc. 2014;62:762-9.
3. Cummings JL, et al. The Neuropsychiatric Inventory (NPI). Neurology. 1994;44:2308-14.
4. Schneider LS, et al. CATIE-AD — antipsicóticos na DA. N Engl J Med. 2006;355:1525-38.
5. FDA. Boxed warning — antipsicóticos em idosos com demência (2005; estendida 2008).
6. FDA. Aprovação do brexpiprazol para agitação na demência da DA. 2023.
7. Porsteinsson AP, et al. CitAD — citalopram para agitação na DA. JAMA. 2014;311:682-91.
8. McKeith IG, et al. Consenso DLB (cautela com antipsicóticos). Neurology. 2017.
9. Diretrizes nacionais: ABN (Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento) e SBGG — conferir versões vigentes.
10. Alexopoulos GS, et al. Escala de Cornell para depressão na demência. Biol Psychiatry. 1988.

Doses, indicações e tarjas seguem bula/diretrizes vigentes e julgamento clínico individual.

CRÉDITOS

Créditos de imagens e nota de marca

Fotografias (licença livre / domínio público — Wikimedia Commons):

- Enfermeira ampara idoso (DOCUMERICA, Bill Strode) — domínio público
- Idosos (Brasil) — Adam Jones · CC BY-SA · Idoso sentado — jaocampo · CC0
- Frasco de comprimidos — Mpelletier1 · CC BY-SA 3.0

Ícones: Font Awesome. **Diagrama DICE e esquemas:** originais desta aula.



Marca institucional: logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG.

Obrigado!

Comportamento é comunicação — **antes do remédio, ache o gatilho.**

Prof. Dr. Igor Morais · CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG

